

• 中国全科医疗 / 社区卫生服务工作研究 •

我国基层卫生服务与管理评价指标体系研究进展

林小洁¹, 杨颖^{2*}, 王皓翔^{1*}

1.510080 广东省广州市, 中山大学公共卫生学院

2.511430 广东省广州市, 广东省疾病预防控制中心 广东省公共卫生研究院

*通信作者: 杨颖, 主任医师/硕士生导师; E-mail: yang99063@126.com

王皓翔, 教授/博士生导师; E-mail: wanghx27@mail.sysu.edu.cn



扫描二维码
查看原文

【摘要】 随着我国基层卫生体系改革的深入推进, 科学、系统的评价指标体系成为衡量基层卫生服务能力与发展水平的关键工具。本文系统梳理了自 2009 年新医改以来, 围绕基层卫生服务与管理方面进行评价的指标体系文献, 涵盖绩效评价、服务能力评价等 6 类主题, 分析其发表时间、研究区域分布、指标特征及研究方法等特点。研究发现, 不同时期研究主题侧重点不同, 现有研究较多集中在东部地区, 研究内容以绩效评价为主, 多采用文献分析法、德尔菲法和层次分析法等构建指标体系。各类指标体系构建有其特点和趋势, 但存在缺乏动态调整机制、应用推广受限及指标选取主观等问题。未来研究应关注服务质量、医防融合等薄弱领域, 结合大数据技术提升指标客观性, 进一步强化动态监测与指标体系现场应用, 以期更全面、精准地反映基层卫生发展的实效, 为政策优化提供参考依据。

【关键词】 基层卫生; 指标体系; 绩效评价; 服务能力评价; 服务质量评价; 家庭医生; 医防融合; 医联体

【中图分类号】 R 197 **【文献标识码】** A DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0373

Research Progress on the Evaluation Indicator System for Primary Healthcare Services and Management

LIN Xiaojie¹, YANG Ying^{2*}, WANG Haoxiang^{1*}

1.School of Public Health, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China

2.Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention / Guangdong Provincial Institute of Public Health, Guangzhou 511430, China

*Corresponding authors: YANG Ying, Chief physician/Master supervisor; E-mail: yang99063@126.com

WANG Haoxiang, Professor/Doctoral supervisor; E-mail: wanghx27@mail.sysu.edu.cn

【Abstract】 With the deepening reform of China's primary health care system, scientific and systematic evaluation indicator systems have become crucial tools for measuring the capacity and development level of primary healthcare services. This article systematically reviewed the literature on evaluation indicator systems for primary healthcare services and management since the 2009 Healthcare Reform, covering six themes including performance evaluation, service capacity assessment, etc. It analyzed characteristics such as publication timeline, geographical distribution of research, indicator features, and research methods used. The study revealed that research themes have varied in focus across different periods. Existing research is concentrated in eastern China, with performance evaluation being the predominant subject. Literature review, the Delphi method, and the Analytic Hierarchy Process have been frequently employed to construct these indicator systems. While various indicator systems demonstrate unique characteristics and trends, limitations exist, including a lack of dynamic adjustment mechanisms, limited application and promotion, and subjectivity in indicator selection. Future research should focus on areas such as service quality and the integration of medical treatment and disease prevention, leveraging big data technology to enhance the objectivity of indicators. Furthermore, strengthening dynamic monitoring and field application of indicator systems is essential to more comprehensively and accurately reflect the effectiveness of primary healthcare development, providing a reference basis for policy optimization.

【Key words】 Primary healthcare; Indicator system; Performance evaluation; Service capability evaluation; Service quality evaluation; Family physician; Medical and preventive integration; Medical alliance

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (72061137002); 广州市卫生健康科技重大项目 (2025A031005)

引用本文: 林小洁, 杨颖, 王皓翔. 我国基层卫生服务与管理评价指标体系研究进展 [J]. 中国全科医学, 2026, 29(10): 1256-1266. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0373. [Epub ahead of print] [www.chinagp.net]

LIN X J, YANG Y, WANG H X. Research progress on the evaluation indicator system for primary healthcare services and management[J]. Chinese General Practice, 2026, 29(10): 1256-1266.

© Editorial Office of Chinese General Practice. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

基层卫生扎根家庭与社区,面向全体居民提供可及性、连续性、综合性的健康服务,是维护居民健康的第一道防线,其质量直接关系全民健康水平和卫生系统整体效率^[1]。为切实提升基层卫生服务能力,《国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知》^[2]及《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体监测指标体系的通知》^[3]等文件,将“完善基层卫生服务绩效考核与监测评价制度”列为重点任务,构建科学适用的基层卫生指标体系对完善基层医疗卫生服务体系具有重要意义。当前,已有研究多聚焦于基层医疗卫生机构、全科医生等单一主体,或围绕卫生应急^[4]、农村地区医疗卫生服务^[5]、全科医生岗位胜任力^[6]等专题构建指标体系,缺乏对基层卫生总体发展情况的系统反映。为进一步全面了解我国基层卫生指标体系构建研究现状,本文聚焦2009年新医改以来基层卫生服务与管理相关的评价指标体系文献,宏观把握现有研究成果侧重点,识别薄弱环节,为明确未来指标体系优化的关键方向提供参考依据,从而更有针对性地提升基层卫生的服务与管理能力,助力健康中国战略目标的实现。

1 研究方法

1.1 文献检索策略

检索中国知网、万方数据知识服务平台、维普网,发表时间设定为2009年3月—2025年7月。检索词包括基层卫生、初级卫生保健、基层医疗卫生(机构/体系)、社区卫生服务(机构)、乡镇卫生院、村卫生室、评价指标(体系)。使用布尔逻辑运算符“OR”或“AND”并依照各数据库检索规则进行相应调整。根据检索结果的数量和质量,对检索式进行修改,增加或减少限定条件,提高检索效率和精度。以中国知网为例,检索式如下:

A: 基层卫生 + 初级卫生保健 + 基层医疗 + 基层医疗卫生 + 社区卫生 + 社区卫生服务中心 + 基本公共卫生 + 街道卫生院 + 乡镇卫生院 + 村卫生室

B: (服务质量 + 服务能力 + 资源配置效率 + 服务绩效) * (评价指标 + 指标体系 + 评价指标体系 + 评估框架 + 评价框架)

主题检索式: 主题 A* 主题 B

1.2 文献筛选标准

纳入标准: (1) 研究对象为基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心/站、社康中心、乡镇卫生院、村卫生室)或其工作人员; (2) 研究内容涉及基层卫生指标体系的构建、应用或评价; (3) 文献来源为学术期刊或博/硕士学位论文。排除标准: (1) 综述类文献,未涉及指标体系构建; (2) 无法获取全文或者研究内容未清晰阐述指标体系构建过程; (3) 重复发表或发表在非核心期刊的文献。

1.3 文献筛选与资料提取

由2名研究者独立检索、筛选文献,意见不一致时,由第3位研究者协助判断。使用EndNote X9管理文献。首先根据题名和摘要进行初筛,排除明显不相关的文献,再通过全文阅读复筛,以确定最终纳入的文献并提取资料。提取内容主要包括:作者、题目、发表年份、研究对象、研究地区、评价方法、评价指标、结果运用情况。

1.4 统计学方法

应用Microsoft Excel软件建立数据库,提取、收集文献信息。计数资料用频数和率表示,并进行描述性分析。

2 结果

2.1 文献检索流程

初始检索得到文献共12 326篇,删除重复文献后纳入题目和摘要筛选7 464篇;根据研究目的、对象及类型进行排除后纳入217篇文献进行主题内容筛选,最终得到38篇文献^[7-44]进行评价指标体系分析(图1)。

2.2 文献研究主题内容

在纳入主题内容筛选的217篇文献中,基层卫生服务与管理相关的指标体系研究主要聚焦以下6类核心方向:绩效评价、能力评价、服务质量评价、家庭医生评价、医防融合评价、医联体建设评价。以绩效评价为研究主题的文献数量最多(80篇,36.9%),其次为家庭医生

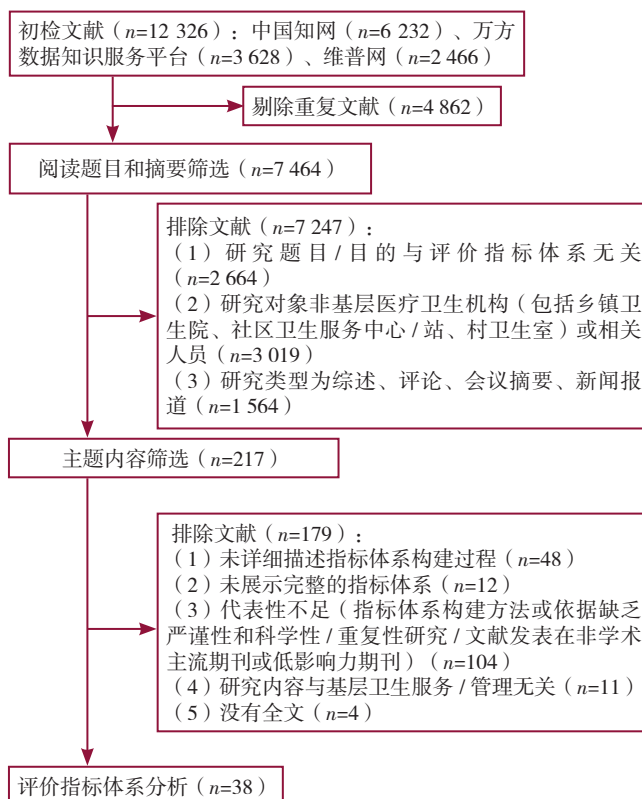


图1 文献检索流程图

Figure 1 Literature search flowchart

相关（57篇，26.3%）和能力评价（36篇，16.6%），以医联体建设评价（22篇，10.1%）、服务质量评价（14篇，6.5%）、医防融合相关（8篇，3.7%）为研究主题的文献数量相对较少（表1）。

2.2.1 文献发表时间分布

绩效评价类指标体系构建文献在2009—2015年占主导地位，但近年来占比呈现明显的持续下降趋势；服务质量评价文献在2009—2025年发表数量相对均衡；能力评价、医联体、医防融合相关指标体系发表时间主要集中在2020年及之后；家庭医生相关的文献从2012年开始，发表数量一直呈现上升趋势，虽在2020—2025年占比略有降低，但仍是重要研究热点（图2）。

2.2.2 文献研究地区分布

指标体系研究主要集中在东部地区，中部和全国性的研究数量占比相对较低，西部地区关于服务质量、能力评价、家庭医生方面的研究数量仅次于东部地区，而关于医联体方面的文献数量占比较低。上述各研究主题均有部分文献未明确说明研究地区（图3）。

2.3 评价指标体系分析

共有38篇（17.5%）文献^[7-44]详细阐述了基层卫生相关的指标体系构建过程，发表于高引用的核心期刊或为博/硕士学位论文。这些文献报道的研究地区覆盖我国东、中、西部和城乡地区，指标体系构建方法大部分采用文献研究法和德尔菲法（表2）。

2.3.1 绩效评价指标体系

童心玥^[11]构建“投入—过程—产出—效果”四维框架，涵盖“资金”“制度”“健康管理”“疾病防控”“健康素养改善”等二级指标，全面反映基本公共卫生服务项目绩效水平。成撒诺等^[9]将绩效细化为“组织管理”“资金管理”“项目执行”“效果”“家庭医生签约”五类一级指标，并构建“健康档案”“重点人群管理”“知晓率与满意度”等二级指标，系统反映基本公共卫生服务从资源投入到服务产出的全过程绩效特征。马新雅

等^[10]针对2型糖尿病患者健康管理，采用“工作保障”“服务落实”“效果”三类一级指标，以及“制度”“人员”“经费保障”“实施进展”“随访”“信息化管理”“社会与经济效益”等二级指标，聚焦专病管理全流程。陶军^[12]从机构层面出发，一级指标包括“公共卫生”“医疗”“综合管理”“社会评价”，二级指标包括“重点人群健康管理”“签约服务”“运营管理”“人员配备”“职工与社会满意度”等，反映基层机构综合绩效。吴腾燕^[13]在以结核病防治为代表的公共卫生专项服务绩效评价中，以“客观工作”“主观效应”为一级指标，二级指标覆盖“患者发现”“治疗”“管理”“健康教育”“质量控制”“培训协调及人员与患者满意度”，精准契合“三位一体”防治模式。整体来看，绩效评价以定量指标为主，部分研究结合定性评估，兼顾宏观资源配置与微观服务效果，可为基层卫生绩效改进提供多维度依据。

2.3.2 服务能力评价指标体系

该类指标体系构建多围绕“资源功能管理—效果”逻辑展开。朱霖^[15]从“基础建设”“基本功能”“管理培训”“需方情况”4个方面，探索了欠发达地区农村社区卫生服务能力评价指标体系的构建。沈明辉等^[18]从“资源配置”“机构运营”“医疗服务水平”“健康管理水平”“职工发展”5个方面，对基层医疗卫生机构服务能力进行评价。在此类研究中，二级指标多从人、财、物、服务等角度，对一级指标展开描述，如“人员配备”^[15-16]、“设施设备”^[15-16]、“基本医疗”^[15]、“健康教育”^[15]、“高血压监测”^[18]、“糖尿病监测”^[18]。总体而言，服务能力评价以定量硬指标占主导地位，主观评价指标作为补充。

2.3.3 服务质量评价指标体系

在纳入的评价服务质量文献中，一级指标的构建参考“结构—过程—结果”经典框架^[22,24]，或从宏观层面概括影响服务质量的关键指标，如“卫生人力资源”“基础设施情况”“基本医疗服务质量”“公共卫生服务质

表1 纳入主题内容筛选的文献研究内容
Table 1 Research content of thematically-screened literature

研究主题（文献数量，篇）	研究具体内容（文献数量，篇）
绩效评价（80）	基本公共卫生服务项目绩效评价（22）、综合绩效（18）、基层医疗卫生机构运营绩效（15）、公共卫生专项（10）、人力资源绩效（8）、医联体绩效（5）、经济绩效（2）
能力评价（36）	基层卫生专项服务能力评价（12）、基层卫生服务机构综合服务能力评价（8）、基层卫生重点人群服务能力评价（5）、基层卫生应急与防控能力评价（7）、基层卫生人员能力评价（4）
家庭医生相关（57）	绩效评价指标体系构建（18）、服务质量评价体系（12）、服务模式与政策效果评估（10）、能力与胜任力评价（8）、特殊人群/场景服务评价（6）、理论框架与概念模型（3）
服务质量评价（14）	基层卫生服务质量综合评价（4）、慢性病与基本公共卫生服务质量评价（3）、农村基层卫生服务质量评价（3）、家庭医生与全科团队服务质量评价（2）、临床药学与专科服务质量评价（1）、医养结合服务质量评价（1）
医联体相关（22）	绩效评价体系构建（8）、专项能力评价（5）、分级诊疗相关评价（3）、可持续发展与脆弱性分析（2）、公共卫生服务评价（2）、综合服务能力评价（2）
医防融合相关（8）	基层医生医防融合服务能力评价（2）、县域医防融合评价指标体系（2）、基层医疗卫生机构医防融合服务质量评价（1）、社区卫生服务中心医防融合效果评价（1）、社区慢性病医防融合程度评价（1）、医防融合概念框架与指标体系构建（1）

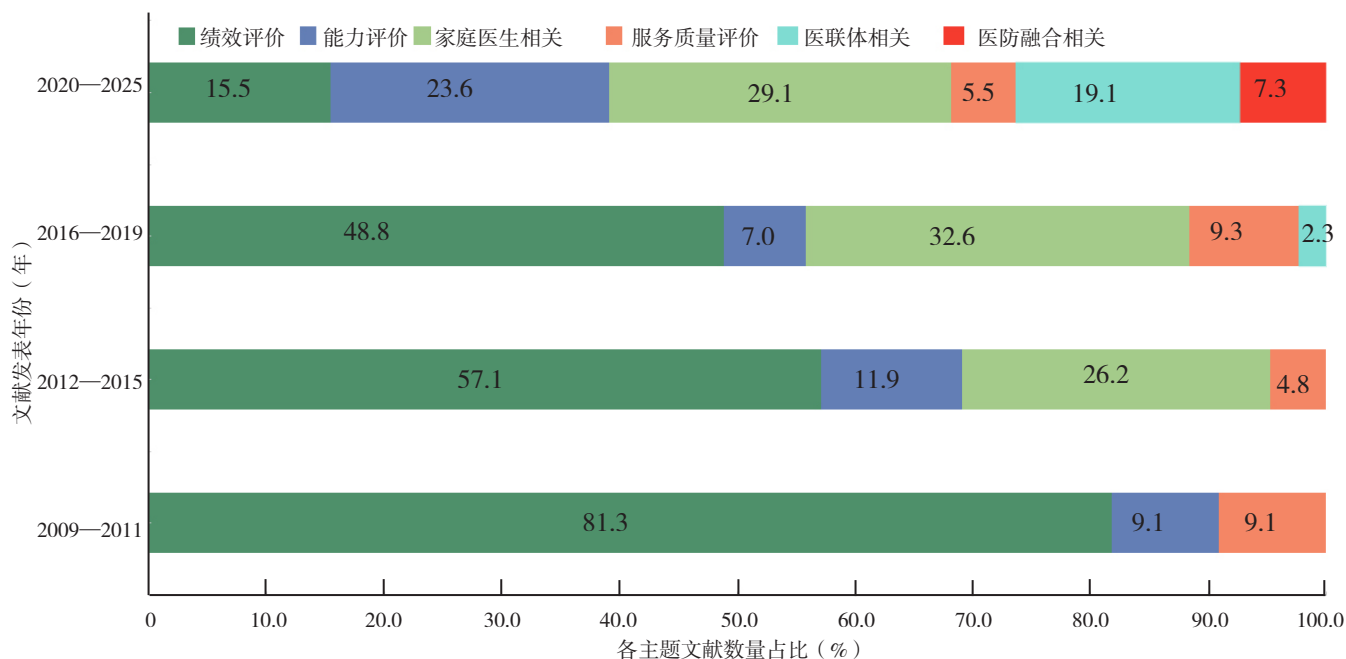


图2 纳入主题内容筛选的文献发表时间分布情况

Figure 2 Temporal distribution of publications of thematically-screened literature

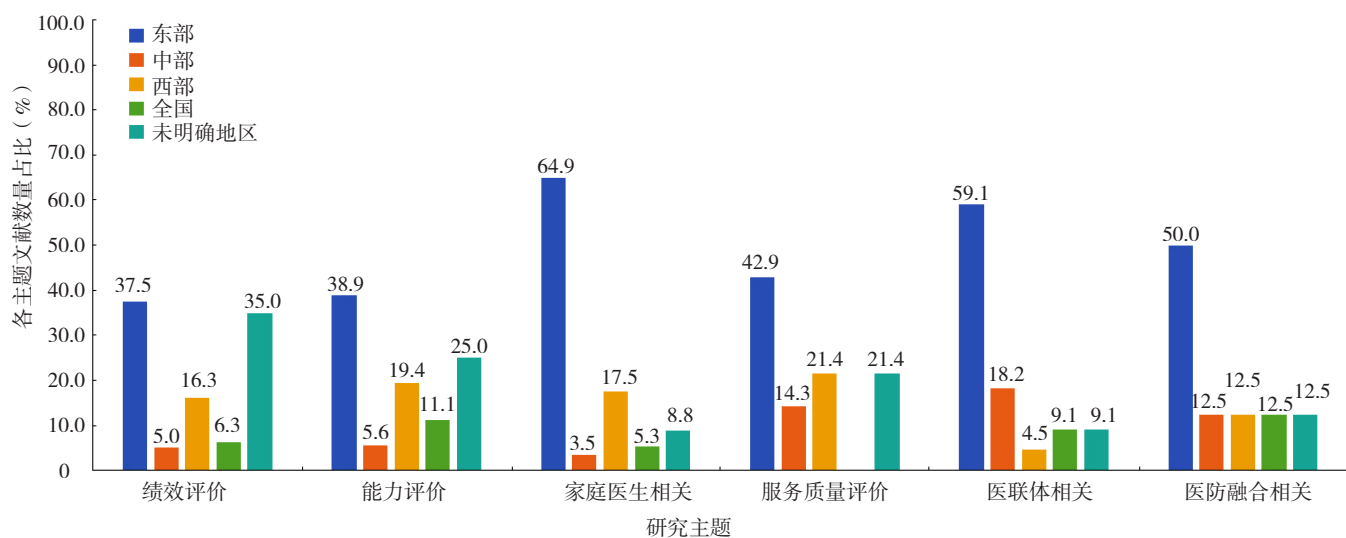


图3 纳入主题内容筛选的文献研究地区分布情况

Figure 3 Regional distribution of thematically-screened literature

量”^[23]。二级指标多从定量角度，如“每千人口村医数量”“每年获得补助经费数”，进一步细化一级指标。陈楠^[25]在甘肃省村卫生室卫生服务质量评价指标体系研究中，将“健康防贫”设为一级维度，同时设计“协助上级卫生部门完成贫困儿童营养包发放”等体现村级网底功能的二级指标，充分考虑乡村医生视角，是一种“自下而上”建立村卫生室卫生服务质量评价指标体系的方法学尝试。整体来看，服务质量评价以定量指标为主，但其中以“满意度”“依从性”等为代表的量表类主观指标占比明显高于绩效与能力评价。

2.3.4 家庭医生相关指标体系

在家庭医生相关研究中，一级指标多聚焦于宏观维度，体现家庭医生服务的全面性和系统性。李薇等^[26]从“签约量”“门诊服务量”“服务效果”“服务知晓利用”“满意度”等维度构建家庭医生工作室服务质量评价指标体系；田淼森等^[29]用2个一级指标“政策执行层”“人际交往能力”评价家庭医生签约服务政策效果；练璐等^[30]从“医疗服务”“公共卫生服务”“组织管理和协调”“职业素养”4个维度构建指标体系评价家庭医生卫生服务能力；孙彩霞等^[33]基于“结构—

表 2 评价指标体系分析文献汇总

Table 2 Summary of evaluation indicator system literature analysis

研究主题	序号	第一作者	年份(年)	题目	评价方法	研究地区	评价指标	结果运用
绩效评价	1	王馨 ^[7]	2014	广东省全科服务团队绩效评价 指标体系的构建与实证性检验	平衡计分卡理论、关键 绩效指标法、文献回顾 和专家访谈	广东省	4个一级指标(“资源维度”“便民性维度”等), 15个二级 指标(“居民全科服务团队满意度”“基本公共卫生服务数量” 等), 34个三级指标(“孕产妇管理效果”“糖尿病管理效果”等)	是
	2	李隆威 ^[8]	2017	基于平衡计分卡理论的广东省 农村乡镇卫生院绩效评价指 标体系的构建	文献研究法、德尔菲法、 平衡计分卡	广东省	4个一级指标(“财务层面”“顾客层面”等), 9个二级指标 (“盈利能力”“卫生服务质量”等), 33个三级指标(“患 者满意度”“健康档案建档率”等)	否
	3	成撒诺 ^[9]	2018	重庆市基本公共卫生服务绩效 考核指标体系构建研究	文献研究法、德尔菲法	重庆市	5个一级指标(“组织管理”“资金管理”等), 26个二级指标(“管 理体系”“预算安排”等), 67个三级指标(“制度建设”“人 员培训”等)	否
	4	马新雅 ^[10]	2018	分级诊疗制度下基层医疗卫生 机构2型糖尿病患者健康管理 绩效评价指标体系的建立	文献研究法、德尔菲法、 层次分析法	四川省	3个一级指标(“工作保障”“服务落实”等), 13个二级指标(“制 度保障”“人员保障”等), 46个三级指标(“构建合格的家 庭医生团队”“机构中心分管领导考核合格”等)	否
	5	童心玥 ^[11]	2019	国家基本公共卫生服务项目绩 效评价研究:以湖北省为例	文献研究法、头脑风 暴法	湖北省	4个一级指标(“投入维度指标”“过程维度指标”等), 13 个二级指标(“资金投入”“资金到位”等), 44个三级指标(“公 共卫生总经费的比重”“居民人均基本公共卫生经费”等)	是
	6	陶军 ^[12]	2022	武汉市基层医疗卫生机构绩效 指标体系构建与评价	文献研究法、德尔菲法	武汉市	4个一级指标(“公共卫生服务”“综合管理”等), 16个二 级指标(“孕产妇健康管理”“人出院诊断符合率”等), 18 个三级指标(“产后访视率”“病种数”等)	是
	7	吴腾燕 ^[13]	2022	“三位一体”防治模式下基层 结核病防治绩效综合评价指 标体系的构建研究:基于德尔 法和层次分析法	文献研究法、德尔菲法、 层次分析法	广西壮 族自治区	2个一级指标(“客观指标”“主观指标”等), 10个二级指标(“患 者发现”“患者治疗”等), 69个三级指标(“肺结核患者接 受治疗率”“病原学阳性患者的治愈率”等)	否
	8	杨光玲 ^[14]	2023	基层卫生组织绩效评价体系构 建及应用研究:以C社区卫生 服务中心为例	文献研究法、案例分 析法、专家咨询法	重庆市	5个一级指标(“财务维度”“客户维度”等), 10个二级指标(“运 营能力”“费用控制”等), 24个三级指标(“药占比”“病 床使用率”等)	是
服务能力 评价	9	朱霖 ^[15]	2010	欠发达地区农村社区卫生服 务能力评价指标体系研究	文献研究法、专题小 组讨论、德尔菲法	江西省	4个方面(“基础建设”“基本功能”“管理培训”等), 15 个角度(“人员配备”“业务用房”“业务用房”等), 145 个三级指标(“卫技人员占职工总数比例”“临床科室设置率”“免 费接种率”等)	否
	10	王晰 ^[16]	2020	基层儿童健康服务能力评价 指标体系探索	文献梳理、专家研讨会	全国	3个一级指标(“资源投入”“服务产出”“服务效果”), 9 个二级指标(“设施设备”“人员配备”等), 15个三级指标 和34个具体指标	否
	11	余伯韬 ^[17]	2022	城市社区中医药服务能力评价 指标体系构建及实证研究	扎根理论、文献分析 法和专家咨询法	广州市	3个一级指标(“服务推力”“服务拉力”等), 6个二级指标 (“基础设施与投入”“人力配备”等), 31个三级指标(“中 医药业务用房面积占比”“中医药设备种类”等)	是
	12	沈明辉 ^[18]	2023	基层医疗卫生机构服务能力 评价指标体系构建与应用: 基于主成分分析法	文献分析、专家咨询 和主成分分析法	四川省	5个一级指标(“资源配置”“机构运营”等), 20个二级指标(“房 屋建筑”“政府补贴”等)	是
	13	黄洁 ^[19]	2024	我国居家社区医养结合服 务能力评价指标研究	文献研究法、德尔菲法	未明确	3个一级指标(“投入”“过程”“结果”), 11个二级指标(“组 织管理”“人力资源投入”“资金投入”等), 36个三级指标(“加 强组织领导”“建立长护险制度”“社区医养信息共享”等)	否
	14	魏戊 ^[20]	2025	基层医疗卫生机构骨健康服 务能力评价指标体系研究	文献研究法、半结构 化访谈法、头脑风暴 法、德尔菲法	未明确	3个一级指标(“资源配置”“基本医疗和公共卫生服务”等), 15个二级指标(“科室设置”“设施设备”等), 40个三级指 标(“设置独立骨健康相关诊疗科室数量”等)	否

(续表2)

研究主题	序号	第一作者	年份(年)	题目	评价方法	研究地区	评价指标	结果运用
服务质量评价	15	李宁秀 ^[21]	2011	四川农村乡镇卫生院服务质量评价指标与TOPSIS分析	专题小组法、专家咨询法与TOPSIS分析方法	四川省	2个一级指标(“医疗机构卫生服务指标”“病患服务消费指标”),5个二级指标(“医疗过程指标”“治疗效果指标”“公共卫生指标”等),23个三级指标(“病床周转次数”“平均住院日”等)	是
	16	谭潇潇 ^[22]	2014	基于因子分析的基本公共卫生服务质量监管指标体系构建	文献法、问卷调查法及专家访谈法	黑龙江省	3个一级指标(“结构”“过程”“结构”),10个二级指标(“领导者的战略”“组织管理”等),45个三级指标(“领导者的执行力”等)	是
	17	刑新 ^[23]	2017	中国西部地区村卫生室服务质量评价指标体系研究:以甘肃省为例	文献研究法、专家访谈、德尔菲法	甘肃省	6个一级指标(“卫生人力资源”“收入和支出情况”等),36个二级指标(“每千人口村医数量”“每年获得补助经费数”等)	是
	18	朱亮 ^[24]	2019	医养结合社区居家养老中心供给服务质量评价指标体系的构建研究	文献研究法、质性访谈和德尔菲法	北京市 天津市 河北省	3个一级指标(“服务结构质量”“服务过程质量”等),15个二级指标(“环境”“制度”等),64个三级指标(“居室环境清洁程度”等)	否
	19	陈楠 ^[25]	2022	甘肃省村卫生室卫生服务质量评价指标体系研究	定性系统评价、德尔菲调查、共识会议法、问卷调查、小组访谈	甘肃省	6个一级指标(“卫生人力资源”“基础设施”等),27个二级指标(“业务用房设置”“季度参加培训学习”等)	是
家庭医生相关	20	李薇 ^[26]	2015	家庭医生工作室服务质量评价指标体系的构建研究	文献研究法、专家咨询法	北京市西城区	5个一级指标(“签约量”“门诊服务量”“服务效果”等),32个二级指标项(“工作室门诊量占机构工作量比例”“签约人数占工作室就诊人数比例”等)	否
	21	徐蕾 ^[27]	2016	家庭医生绩效考核指标体系的构建研究	文献研究法、专家咨询法	上海市	7个一级指标(“资料信息化管理”“签约”等),17个二级指标(“完整性”“准确性”等),29个三级指标(“健康档案完整性”“评估手册完整性”等)	否
	22	欧伟麟 ^[28]	2018	基于德尔菲法的广东省全科团队家庭医生式签约服务绩效考核指标体系构建研究	文献回顾法、德尔菲法	广东省	3个一级指标(“协作能力”“服务效率”“居民满意度”),6个二级指标(“团队成员培训率”“双向转诊及时率”等),20个三级指标(“年度培训时长”“危急重症转诊时间”“重点人群续约覆盖率”等)	否
	23	田森森 ^[29]	2020	家庭医生签约服务政策效果评价指标体系研究	文献分析、专家座谈、德尔菲专家咨询法	未明确	2个一级指标(“政策执行层”“人际交往能力”),7个二级指标(“签约主体及内容”“组织管理”等),23个三级指标(“每万人口全科医生数”“家庭医生签约服务宣传程度”等)	否
	24	练璐 ^[30]	2021	应用改良德尔菲法构建我国家庭医生卫生服务能力指标体系	文献研究法、政策研究、改良德尔菲法(即函询与专家讨论相结合)	青海省 甘肃省 浙江省 安徽省	4个一级指标(“政策执行层”“人际交往能力”等),17个二级指标(“签约主体及内容”“组织管理”等),41个三级指标(“每万人口全科医生数”“家庭医生签约服务宣传程度”等)	否
	25	刘畅畅 ^[31]	2021	农村家庭医生岗位胜任力指标体系构建	文献研究法与德尔菲法、层次分析法	湖北省	6个一级指标(“成就与行动”“协助与服务”等),16个二级指标(“成就导向”“人际理解力”等),59个三级指标(“发挥健康守门人职责”“基本人际沟通能力”等)	否
	26	张璟瑜 ^[32]	2021	家庭医生签约服务团队内部考核指标体系构建研究	文献研究法、德尔菲法	四川省成都市	3个一级指标(“面对面服务”“非面对面服务”等),10个二级指标(“体检”“疫苗”等),23个三级指标(如“评估”“通知”等)	否
	27	孙彩霞 ^[33]	2021	我国家庭医生签约服务绩效考核指标体系构建研究	文献研究法、德尔菲法	全国	3个一级指标(“结构质量”“过程质量”等),10个二级指标(“团队规划”“人才队伍”等),59个三级指标(“成立工作领导小组”“建立完善服务团队”等)	否

(续表 2)

研究主题	序号	第一作者	年份(年)	题目	评价方法	研究地区	评价指标	结果运用
医防融合相关	28	袁蓓蓓 ^[34]	2022	基层卫生服务医防融合:概念框架及指标体系构建	文献综述、专家咨询	广西壮族自治区	5个一级指标(“个人水平医防融合”“机构水平医防融合”等),16个二级指标(“融合服务能力”“融合服务意识”等),28个三级指标[“医务人员对跨预防/医疗知识了解程度(自评)”“医务人员对整合型服务的知识储备水平(自评)”等]	是
	29	张县 ^[35]	2022	社区慢病医防融合程度评价指标体系构建研究	文献研究法、德尔菲法、层次分析法	未明确	5个一级指标(“系统整合”“组织整合”等),14个二级指标(“出台政策”“运行经费”“治理架构”等),32个三级指标(“发展政策”“医保政策”“人均经费”“统筹管理”等)	否
	30	李灿灿 ^[36]	2022	县域医防融合评价指标体系研究	文献复习、访谈法、德尔菲法、专家咨询法	未明确	6个一级指标(“制度融合”“组织融合”等),15个二级指标(“管理制度”“工作制度”等),37个三级指标(“公共卫生机构参与医防融合工作”“医疗卫生机构间签订医防融合工作协议”等)	否
	31	郭佳 ^[37]	2023	基层医疗卫生机构慢性病医防融合服务质量现场评价指标体系构建	文献分析法、政策归纳法、专家访谈法	天津市	5个一级指标(“服务团队”“服务设施”等),12个二级指标(“人员配备”“诊疗设备”等),40个三级指标(“日均负担服务人次”“全员参与培训”等)	否
	32	兰晓霞 ^[38]	2024	基层全科医生医防融合能力评价指标体系构建	文献回顾法、改良的德尔菲法、层次分析法	未明确	3个一级指标(“知识结构方面的医防融合能力”“能力、技能、技术方面的医防融合能力”等),10个二级指标(“基层医学基础知识”“职业素养”等),36个三级指标(“社区管理能力”“掌握合理用药及预防知识”等)	否
	33	陈存川 ^[39]	2024	基层医生医防融合服务能力评价指标体系的构建与应用研究	德尔菲法、层次分析法、问卷调查法	山东省聊城市、潍坊市、烟台市	3个一级指标(“职业素养”“综合服务能力”等),9个二级指标(“职业态度”“职业意识”等),26个三级指标(“人民至上,维护人民健康权利”“平等对待每个人,尊重人格与权利”等)	否
医联体相关	34	周心舒 ^[40]	2020	紧密型医联体协同能力评价指标体系研究:以广州市某紧密型医联体为例	文献研究法、专家咨询法、层次分析法、模糊综合评价法	广州市	5个一级指标(“信息协同能力”“战略协同能力”等),10个二级指标(“信息系统资源”“信息协同过程能力”等),35个三级指标(“信息系统建设情况”“信息系统运行效率”等)	是
	35	林陶玉 ^[41]	2022	区域医联体背景下医养结合服务评价指标体系构建	文献研究法、德尔菲法、层次分析法	未明确	6个一级指标(“治理与监督”“服务协同”等),24个二级指标(“医养结合地方政策”“资源配置”等),48个三级指标(“医联体分配激励机制”“老年人健康管理率”等)	否
	36	刘曦 ^[42]	2022	基于整合型医疗卫生服务体系的广西紧密型县域医共体绩效评价研究	文献研究法、德尔菲专家咨询法	广西壮族自治区	5个一级指标(“系统整合”“资源整合”等),16个二级指标(“外部治理机制”“内部管理机制”等),59个三级指标(“医共体内落实财务统一管理”“医共体内开展药品耗材统一管理”等)	是
	37	章珂 ^[43]	2023	基于 AHP-TOPSIS 法的海南省县域医共体建设运行评价指标体系研究	文献分析法、半结构化访谈、德尔菲专家咨询法、层次分析法、加权 TOPSIS 法	海南省	5个一级指标(“组织治理”“可持续发展”等),15个二级指标(“组织架构”“政府支持”等),58个三级指标[“成立管委会(是/否)”“组建医共体(是/否)”等]	是
	38	张珺茹 ^[44]	2023	紧密型医联体医保支付方式改革绩效评价指标体系构建研究	文献分析法、半结构化访谈、专家咨询法、层次分析法、加权 TOPSIS 法	安徽省、浙江省	3个一级指标(“组织管理”“运行情况”等),9个二级指标(“内部治理”“政策环境”等),30个三级指标(“医保基金结余是否留用与分配”“医保基金超支是否合理分担”等)	否

过程-结果”框架评价家庭医生签约服务绩效。二级指标则更具体,多为可操作、量化的服务内容,涵盖“临床服务”“公共卫生服务”“团队协作”“服务质量”等关键环节,如“签约人数占就诊人数比例”“高血压控制率”“健康知识知晓率”“常见病诊治”“合理用药”“社区康复服务”等。

2.3.5 医防融合相关指标体系

以医防融合为主题的一级指标和二级指标多聚焦于宏观维度,涵盖“个人水平医防融合”“体系水平医防

协作”^[34]等效果评价维度及“职业素养”“综合服务能力”“专业知识技能”^[39]等能力评价维度。在效果评价和能力评价中,均强调多维度整合,如“系统整合”“组织整合”^[35]、“制度融合”^[36]、“组织融合”^[36],体现医防融合的系统性。

2.3.6 医联体相关指标体系

在医联体评价研究中,一级指标普遍聚焦于“治理”“整合”“效率”“效益”等宏观维度,体现医联体的运行逻辑与政策导向。刘曦^[42]围绕“系统整合”“资

源整合”“服务整合”“整合效果”“服务影响”展开,强调整合型服务体系的全流程管理。章珂^[43]从“组织治理”“可持续发展”“效率提升”“资源贯通”“效能效益”等维度构建指标体系,突出县域医共体的治理结构与运行效率。张珺茹^[44]聚焦医保支付方式改革,构建“组织管理”“运行效率”“社会结果”3个维度,突出医保支付方式改革的绩效导向。二级指标涵盖“组织架构”“建章立制”“人员协作”“资源共享”“服务质量”“费用控制”“医保使用效能”等关键环节。与上述5类相比,医联体指标体系的宏观治理与政策导向特征最为突出。

3 讨论

3.1 研究主题分类特征

从研究主题来看,绩效评价类文献数量最多,这可能是由于绩效评价是衡量基层卫生工作成效的关键环节,直接关系到资源分配、政策调整及服务质量提升等诸多重要方面。自2009年新医改以来,我国政府对基层医疗卫生机构投入不断增加,同时对投入产出效益提出更高要求。《关于加强基层医疗卫生机构绩效考核的指导意见(试行)》^[45]等文件的发布,明确将绩效考核作为提升基层服务质量和效率、优化资源配置、激发机构活力的重要“抓手”。这种自上而下的政策推动,促进绩效评价成为基层管理的核心工具,与机构运营资金、人员薪酬,甚至存续发展具有直接关系。政府、医疗机构及研究者都对其给予高度关注,探索基于科学且合理的绩效评价体系,以激励基层医疗卫生机构的职责履行,提高服务效率和质量。家庭医生主题的相关文献数量次之,反映了近年来在我国政府大力推行家庭医生制度的背景下,学术界对家庭医生服务模式、服务质量、政策效果等方面的持续关注。

以服务质量评价和医防融合为研究主题的相关文献数量较少,可能与这些领域的研究难度较大、涉及因素复杂有关。服务质量评价需要综合考虑多方面因素,且不同地区、不同人群对服务质量的期望和评价标准存在差异,难以形成统一且全面的评价体系。在国家卫生健康委《关于做好2018年家庭医生签约服务工作的通知》^[46]的政策文件中,提出以家庭医生团队为基础,根据签约居民需求提供医防融合、综合连续的医疗卫生等服务;但如何推动医疗服务与疾病预防深度融合并形成一体化评价体系,仍存在较大研究空白。前期基层医疗卫生机构多重视基本医疗服务提供和绩效达标,医防融合实践经验相对缺乏,政策指导和具体考核细则处于逐步完善阶段,加之涉及卫生、医保等多部门协作,数据壁垒、利益协同等问题导致整合性评价指标体系构建和验证更具难度。服务效果常体现在居民健康水平的长

期改善,而非短期内可量化的服务产出,这使得研究成果的呈现周期较长,在一定程度上也限制了研究热度。随着基层卫生评价从单一绩效向患者体验延伸,国际工具如初级卫生保健评价工具(PCAT)在我国应用于慢性病患者对连续性、协调性等核心服务特征的量化体验评估^[47],为服务质量评价等薄弱领域提供了新的研究思路。

以紧密型县域医共体为典型代表的医联体建设,是我国深化医改、提升基层服务能力的重大举措,政策推动力度大。作为一种全新的管理组织模式,医联体内部的资源整合、分工协作、双向转诊等机制仍在探索中,评价体系也处于不断完善阶段。政策细化和实践经验积累的相对滞后,可能是相关文献较少的原因。能力评价常作为绩效评价的组成部分出现,这可能与基层能力建设长期以来更侧重于硬件投入、基础设施建设,而非系统性的服务能力和管理能力评估有关。随着医改从“量的积累”转向“质的提升”,学界对基层服务内涵和能力建设的关注度日益提高^[48],更为精细化的能力评价研究有望增加。

3.2 文献发表时间特征

2009—2025年,绩效评价类文献在各类主题中均占有一定比重,表明该领域是基层卫生研究的持续热点。对评价指标体系的不断探索和完善,有助于适应不断变化的基层卫生服务需求和政策环境。自《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》^[49]这份纲领性文件发布,家庭医生相关文献从2012年开始,发表数量一直呈现上升趋势;2016年《关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知》^[50]的发布推动了研究文献数量快速增长,2022年《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》^[51]进一步促进了相关研究成为热点。

服务质量评价类研究数量占比虽然较低,但在这4个时间段也保持了相对均衡。能力评价、医联体、医防融合相关这三类文献发表时间主要集中在2020年及之后,这可能与《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体建设评判标准和监测指标体系(试行)的通知》^[52]、《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》^[53]等政策的出台密切相关。各主题发文时间特点反映了我国医改进入深水區后,关注点从初期强调机构运营效率和服务模式向更深层次的体系整合、服务内涵提升和功能转型转变。同时,基层卫生指标体系研究的时间分布特征与政策导向密切相关,充分体现了基层卫生研究对国家战略需求的积极响应。

3.3 研究区域分布特征

上述6类指标体系研究主要集中在我国东部地区,中部和全国性的研究数量占比相对较少,推测这可能与东部地区经济发展水平较高、医疗卫生资源相对丰富、

科研力量较强有关。同时,政策驱动下的评估需求,可能是导致东部地区相关研究集中的一个重要因素。东部地区作为前沿阵地,在各项改革政策推进中常承担“试验田”的角色。特别是在医疗卫生体制改革方面,如分级诊疗、医联体建设、家庭医生签约服务、医保支付方式改革等创新举措,较多在东部地区率先试点和推广。这些先行先试不仅催生了大量新的服务模式和管理机制^[54],也对构建科学合理的评价指标体系,开展评估、监测和反馈提出了迫切需求。西部地区在多个研究主题上文献数量少于东部地区,可能与西部地区对提升基层卫生服务能力、提高服务质量的需求程度,以及医联体建设起步较晚、发展相对滞后有关^[55]。在纳入的文献中,全国性研究数量也不多,提示现有研究多基于区域实践经验总结,在跨区域的研究成果推广性方面仍然受限。

3.4 研究指标内涵特征

基层卫生服务与管理相关的指标体系构建在纳入的文献中呈现3个核心特点。一是定量指标占据主导地位,而主观指标则侧重于服务质量与效果的感知。在绩效、服务能力评价、家庭医生、医联体相关等类别的二级指标中,以“每千人口村医数量”^[23]、“牵头医院床位使用率”^[43]等定量指标为主,强调数据的可获取性和可比性,这与基层卫生量化考核的需求相契合。服务质量评价侧重于居民体验与健康结果的长期追踪,“居民满意度”^[8]、“健康知识知晓率”^[26]等主观量表类指标占比相对较高。二是指标设计体现了从宏观到微观的分层逻辑,普遍从“服务质量”“服务能力”“医防融合”等宏观目标出发,通过二级指标逐步延伸至“资源投入”“管理流程”“村医数量”“随访频次”等具体操作层面,形成完整体系构建。例如,家庭医生签约服务的一级指标“服务效果”,可通过“高血压控制率”“糖尿病控制率”^[26]等二级指标进行评估。三是政策导向特征显著,整合性指标日益凸显。医防融合、医联体等指标体系由于涉及多部门协作与多机构联动,其一级指标通常强调“系统整合”“制度融合”^[36]等,二级指标则聚焦于跨领域协同的能力等方面,如“信息协同过程能力”“整体层面战略协同能力”^[40]等。相比而言,服务质量、服务能力等传统评价更加侧重单一维度的硬性指标,整合性相对较弱。

4 现有研究的局限性与未来研究建议

4.1 指标体系的区域适应性有待优化

现有研究多集中于特定地区,对地区间的差异考虑尚不够充分。我国地域辽阔,不同地区的经济发展水平、人口结构、医疗卫生资源分布等存在显著差异^[55],可对基层卫生服务的需求、供给以及服务质量等产生重要影响。指标体系如未充分考虑这些地区差异,则无法准

确反映各地区基层卫生发展状况。对于经济发达地区,建议注重基层卫生服务的创新性和高质量发展,采用可反映新技术应用、服务模式创新等方面的指标;对于经济欠发达地区,建议重点关注基本医疗卫生服务的保障和可及性,采用可反映医疗资源配备、服务覆盖范围等方面的指标。下一步可探索构建“核心指标集+区域特色指标”的弹性评价框架,在全国普适性核心指标基础上,允许各地区根据经济发展水平、人口结构、疾病谱等实际情况,灵活增设或调整有地方特色的指标及其权重,以确保评价体系既能反映全国整体情况,又能兼顾地方差异化需求。

4.2 指标体系的动态性有待提高

在人工智能、智慧医疗等背景下,基层卫生评价指标体系也面临重大变革机遇窗口。基层卫生是一个不断发展和变化的领域,随着技术进步、政策调整、社会需求变化,基层卫生服务与管理相关的内容和模式也在不断演变。然而,现有研究中的指标体系大多缺乏动态调整机制,无法及时反馈基层卫生的最新变革。未来研究可探索构建弹性评价框架,在指标设计中预留“动态指标模块”,允许各地根据实际调整部分指标权重或新增特色指标;同时加强信息化技术应用,依托区域卫生信息平台,整合医疗机构信息系统、公共卫生信息系统等数据源,建立常态化数据采集分析机制,为指标体系的动态优化提供数据支撑。具体而言,可以探索利用可穿戴设备、智能居家健康监测设备等,实时采集健康数据(如血压、心率等),以及通过移动健康应用获得患者自我报告健康数据和体验反馈。利用大数据技术,对上述实时监测数据、患者生成数据、传统电子健康档案等数据进行整合分析,更及时和全面地评价基层卫生服务的长期健康结果。在健康趋势变化、高风险人群动态演变的识别基础上,快速调整评价指标的权重和关注点,将有助于提升指标体系时效性与适应性,为基层卫生高质量发展提供更合理的参考依据。

4.3 指标体系的实证反馈有待完善

当前纳入文献所构建的指标体系,多数尚未在实际场景中进行广泛应用与验证,其适用性与有效性有待实证检验。未来的研究应加强与基层医疗卫生机构的合作,将指标体系应用于实践,并对应用效果进行评估与反馈,不断完善指标体系。

4.4 指标体系构建方法学有待创新

现有研究多采用传统的德尔菲法等专家咨询法进行指标选取,在方法学上缺乏创新,且专家意见可能存在主观性。未来研究应充分利用大数据、人工智能等技术,加强客观数据的收集与分析,挖掘影响基层卫生服务质量等的关键因素。具体而言,通过对电子健康档案、医保结算及公共卫生监测等数据的标准化和结构化整合,

形成可全面反映基层医疗卫生服务全貌的数据池。在此基础上,深入挖掘数据背后隐藏的规律和复杂关联,自动识别、筛选并优化指标。例如通过机器学习分析大规模医保结算数据,可精准定位高费用风险人群及其关键驱动因素,量化评估不同基层干预措施的实际效果(如降低住院及再入院的具体比例),为制定针对性的预防策略和资源配置方案提供依据,优化“控费增效”类绩效指标。又例如通过对患者的诊疗大数据和健康结局的分析,识别与基层卫生服务质量、患者满意度或特定疾病管理效果密切相关的变量。相较于专家经验,基于数据驱动的因素更具客观性和实证基础,合理利用数智技术有助于更好地反映基层卫生的真实运行状态和影响因素,为政策制定和干预措施优化提供坚实数据支撑。

基层卫生服务与管理评价指标体系建设是一项持续改进的工程。在绩效评价方面,有助于引导资源配置与提升效率,激励基层优化管理;在服务能力评价方面,有助于发现和找出服务的薄弱环节,解决“基层是否有能力提供优质服务”的问题,为制定人才培养、设备更新等长期规划提供依据;在服务质量和家庭医生相关评价方面,有助于提升居民健康体验与健康结局,推动基层服务“以患者为中心”的持续服务优化;在医防融合及医联体相关评价方面,有助于促进系统整合与协同照护,提升基层医疗卫生服务在疾病预防、健康促进与医疗服务之间的整合程度及资源整合、服务协同的整体效益,推动分级诊疗的落地。总之,未来研究应在现有研究的基础上,更加注重指标体系的动态性,加强指标体系的应用与推广,为提升基层卫生服务以及管理能力,实现健康中国战略目标提供有力支撑。

作者贡献:林小洁负责构思全文,筛选文献,撰写论文,整理图表;杨颖负责筛选文献,实施指导与项目监督;王皓翔负责文献筛选,文章的质量控制及审校,对文章整体负责。

本文无利益冲突。

参考文献

- [1] 国家卫生健康委,中央编办,国家发展改革委,等.关于优化基层医疗卫生机构布局建设的指导意见:国卫基层发〔2025〕2号[A/OL].(2025-04-25)[2025-08-08].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202505/content_7022246.htm.
- [2] 国务院办公厅.国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知:国办发〔2022〕11号[A/OL].(2022-04-27)[2025-08-08].https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-05/20/content_5691424.htm.
- [3] 国家卫生健康委办公厅,国家医保局办公室,国家中医药局综合司.关于印发紧密型县域医疗卫生共同体监测指标体系的通知:国卫办基层发〔2024〕22号[A/OL].(2024-10-30)[2025-08-08].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6984315.htm.
- [4] 袁素维,祝翠悦,蒋琦蕴,等.我国公立医疗机构卫生应急能力评价指标体系研究现状与进展[J].中国医院管理,2022,42(12):35-39.
- [5] 许诗瑶,陈焯至,廖鹏,等.中国农村基本医疗卫生服务综合评价指标体系构建的定性系统评价[J].中国卫生资源,2021,24(1):62-70. DOI: 10.13688/j.cnki.chr.2021.200170.
- [6] 魏云,王飞跃,王美荣,等.我国全科医生岗位胜任力评估指标体系研究进展[J].中国全科医学,2021,24(19):2394-2400. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.103.
- [7] 王馨.广东省全科服务团队绩效评价指标体系的构建与实证性检验[D].广州:广州医科大学,2014.
- [8] 李隆威,赵宇,温佳欣,等.基于平衡计分卡理论的广东省农村乡镇卫生院绩效评价指标体系的构建[J].中国医药导报,2017,14(19):145-149.
- [9] 成撒诺,何坪,邓宇,等.重庆市基本公共卫生服务绩效考核指标体系构建研究[J].中国全科医学,2018,21(10):1161-1166.
- [10] 马新雅,关旭静,唐雪峰,等.分级诊疗制度下基层医疗卫生机构2型糖尿病患者健康管理绩效评价指标体系的建立[J].现代预防医学,2019,46(3):467-471.
- [11] 童心玥.国家基本公共卫生服务项目绩效评价研究:以湖北省为例[D].武汉:华中科技大学,2018.
- [12] 陶军.武汉市基层医疗卫生机构绩效指标体系构建与评价[D].武汉:华中科技大学,2020.
- [13] 吴腾燕.“三位一体”防治模式下基层结核病防治绩效综合评价指标体系的构建研究:基于德尔菲法和层次分析法[J].广西人文医学发展报告,2022(1):369-379.
- [14] 杨光玲.基层卫生组织绩效评价体系构建及应用研究:以C社区卫生服务中心为例[D].石家庄:河北师范大学,2023.
- [15] 朱霖.欠发达地区农村社区卫生服务能力评价指标体系研究[D].南昌:南昌大学,2010.
- [16] 王晰,殷涛,政晓果,等.基层儿童健康服务能力评价指标体系探索[J].中国卫生经济,2020,39(5):60-63. DOI: 10.7664/CHE20200516.
- [17] 余伯韬.城市社区中医药服务能力评价指标体系构建及实证研究[D].广州:南方医科大学,2022.
- [18] 沈明辉,刘洋,毛云鹏,等.基层医疗卫生机构服务能力评价指标体系构建与应用:基于主成分分析法[J].卫生经济研究,2023,40(11):39-43. DOI: 10.14055/j.cnki.33-1056/f.2023.11.006.
- [19] 黄洁.我国居家社区医养结合服务能力评价指标研究[D].北京:北京协和医学院,2023.
- [20] 魏戎,尹煜辉,王旭,等.基层医疗卫生机构骨健康服务能力评价指标体系研究[J].中国全科医学,2025,28(19):2354-2362. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0024.
- [21] 李宁秀,柯雄.四川农村乡镇卫生院服务质量评价指标与TOPSIS分析[J].中国卫生事业管理,2011,28(10):776-778. DOI: 10.3969/j.issn.1004-4663.2011.10.023.
- [22] 谭潇潇,樊立华,谢明霁,等.基于因子分析的基本公共卫生服务质量监管指标体系构建[J].中国卫生经济,2014,33(5):49-50.
- [23] 邢新.中国西部地区村卫生室服务质量评价指标体系研究:以甘肃省为例[D].兰州:兰州大学,2017.
- [24] 朱亮.医养结合社区居家养老中心供给服务质量评价指标体系构建[D].唐山:华北理工大学,2019.
- [25] 陈楠.甘肃省村卫生室卫生服务质量评价指标体系研究[D].兰

- 州:兰州大学,2022.
- [26] 李薇,彭迎春.家庭医生工作室服务质量评价指标体系的构建研究[J].中国全科医学,2015,18(22):2632-2636.
 - [27] 徐蕾,赵琦,朱敏杰,等.家庭医生绩效考核指标体系的构建研究[J].中国全科医学,2016,19(25):3028-3032.
 - [28] 欧伟麟,沈欢瑜,欧文森,等.基于德尔菲法的广东省全科团队家庭医生式签约服务绩效考核指标体系构建研究[J].中国全科医学,2018,21(7):795-799.
 - [29] 田森森,王芳,贾梦,等.家庭医生签约服务政策效果评价指标体系研究[J].中华医院管理杂志,2020,36(7):553-556. DOI:10.3760/cma.j.cn111325-20200408-01051.
 - [30] 练璐,李心怡,邹慕蓉,等.应用改良德尔菲法构建我国家庭医生卫生服务能力指标体系[J].中国卫生资源,2021,24(4):448-452. DOI:10.13688/j.cnki.chr.2021.200914.
 - [31] 刘畅畅,高红霞,张研.农村家庭医生岗位胜任力指标体系构建[J].医学与社会,2021,34(1):20-24,33.
 - [32] 张璟瑜,刘利霞,王小刚,等.家庭医生签约服务团队内部考核指标体系构建研究[J].中国全科医学,2021,24(25):3244-3249. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.147.
 - [33] 孙彩霞,司骊骏,蒋锋,等.我国家庭医生签约服务绩效评价指标体系构建研究[J].中国全科医学,2021,24(34):4378-4385. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.249.
 - [34] 袁蓓蓓,何平,徐进,等.基层卫生服务医防融合:概念框架及指标体系构建[J].中国卫生政策研究,2022,15(9):11-18.
 - [35] 张县.社区慢病医防融合程度评价指标体系构建研究[D].北京:北京中医药大学,2022.
 - [36] 李灿灿.县域医防融合评价指标体系研究[D].合肥:安徽医科大学,2022.
 - [37] 郭佳,孙华君,陈营,等.基层医疗卫生机构慢性病医防融合服务质量现场评价指标体系构建[J].中国全科医学,2023,26(28):3489-3495. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0277.
 - [38] 兰晓霞,杨朝晖,岳帅,等.基层全科医生医防融合能力评价指标体系构建[J].健康发展与政策研究,2024,27(2):148-156.
 - [39] 陈存川.基层医生医防融合服务能力评价指标体系的构建与应用研究[D].济南:山东大学,2024.
 - [40] 周心舒.紧密型医联体协同能力评价指标体系研究:以广州市某紧密型医联体为例[D].广州:广州医科大学,2020.
 - [41] 林陶玉,唐昌敏.区域医联体背景下医养结合服务评价指标体系构建[J].医学与社会,2022,35(11):38-43,49.
 - [42] 刘曦.基于整合型医疗卫生服务体系的广西紧密型县域医共体绩效评价研究[D].南宁:广西医科大学,2022.
 - [43] 章珂.基于AHP-TOPSIS法的海南省县域医共体建设运行评价指标体系研究[D].海口:海南医学院,2023.
 - [44] 张珺茹.紧密型医联体医保支付方式改革绩效评价指标体系构建研究[D].南昌:江西中医药大学,2022.
 - [45] 基层卫生健康司.关于加强基层医疗卫生机构绩效考核的指导意见(试行):国卫办基层发〔2020〕9号[A/OL].(2020-08-17)[2025-08-08].<http://www.natcm.gov.cn/yizhengsi/zhengcewenjian/2020-08-17/16488.html>.
 - [46] 国家卫生健康委员会办公厅.关于做好2018年家庭医生签约服务工作的通知:国卫办基层函〔2018〕209号[A/OL].(2018-04-02)[2025-08-08].<https://www.nhc.gov.cn/jws/e100073/201804/abc630c492914e2c8ed6a3790dba1fff.shtml>.
 - [47] HU X J, WANG H H X, LI Y T, et al. Healthcare needs, experiences and treatment burden in primary care patients with multimorbidity: an evaluation of process of care from patients' perspectives[J]. Health Expect, 2022, 25(1): 203-213. DOI:10.1111/hex.13363.
 - [48] 李梓齐,何平,袁蓓蓓,等.“以基层为重点”的县域卫生体系发展指数构建与应用案例分析[J].中国全科医学,2023,26(25):3147-3152.
 - [49] 国务院.国务院关于建立全科医生制度的指导意见:国发〔2011〕23号[A/OL].(2011-07-01)[2025-08-08].https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1907087.htm.
 - [50] 国务院医改办,卫生计生委,发展改革委,等.关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知:国医改办发〔2016〕1号[A/OL].(2016-05-25)[2025-08-08].<https://www.bjxch.gov.cn/f/170322/76418.pdf>.
 - [51] 国家卫生健康委,财政部,人力资源社会保障部,等.关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见:国卫基层发〔2022〕10号[A/OL].(2022-03-03)[2025-08-08].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/15/content_5679177.htm.
 - [52] 国家卫生健康委办公厅,国家医保局办公室,国家中医药局办公室.关于印发紧密型县域医疗卫生共同体建设评判标准和监测指标体系(试行)的通知:国卫办基层发〔2020〕12号[A/OL].(2020-08-31)[2025-08-08].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/18/content_5544471.htm.
 - [53] 中共中央办公厅,国务院办公厅.关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见[A/OL].(2023-03-23)[2025-08-08].https://www.gov.cn/zhengce/2023-03/23/content_5748063.htm.
 - [54] 王震,朱凤梅.中国医疗卫生改革十年(2009—2019)研究报告[EB/OL].(2019-12-19)[2025-08-08].<https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1d7a0xe0cx2e0xy04f5u0x20q4215378>.
 - [55] 支涵颖.全国基层医疗卫生资源区域性配置差异研究[J].社会科学前沿,2024,13(5):410-418.
- (收稿日期:2025-11-12;修回日期:2025-12-03)
(本文编辑:王凤微)